Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области
«Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер»
(ГБУЗ МО «МОКПТД»)

ПРИКАЗ

«14» июля 2025 № 109/25

Об организации деятельности по мониторингу эффективности и безопасности лекарственных препаратов для медицинского применения

В целях организации мониторинга эффективности и безопасности лекарственных препаратов для медицинского применения (далее – лекарственных препаратов), направленного на выявление, оценку и предотвращение нежелательных последствий применения лекарственных препаратов в соответствии с частью 3 статьи 64 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», пунктом 4.8 приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2012 № 502н «Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации», приказа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 17.06.2024 № 3518 «Об утверждении Порядка фармаконадзора лекарственных препаратов для медицинского применения»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать работу в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Московской области «Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер» (далее по тексту – ГБУЗ МО «МОКПТД») по регистрации случаев побочных действий лекарственных препаратов, нежелательных реакций, серьезных нежелательных реакций, непредвиденных нежелательных реакций при применении лекарственных препаратов, индивидуальной непереносимости, отсутствии эффективности лекарственных препаратов (далее – нежелательных побочных реакций, НПР), а также об иных фактах и обстоятельствах, представляющих угрозу жизни или здоровью человека при применении лекарственных препаратов, выявленных на всех этапах обращения лекарственных препаратов.
2. Локальным нормативным актом, по филиалам и клиникам, назначить ответственного за сбор, обработку, представление информации ответственному за мониторинг нежелательных реакций (клинический фармаколог или назначаемый сотрудник).
3. Утвердить:
3.1 Порядок регистрации случаев побочных действий лекарственных препаратов, нежелательных реакций, серьезных нежелательных реакций, непредвиденных нежелательных реакций при применении лекарственных препаратов, индивидуальной

непереносимости, отсутствии эффективности лекарственных препаратов, а также иных фактов и обстоятельств, представляющих угрозу жизни или здоровью человека при применении лекарственных препаратов в ГБУЗ МО «МОКПТД» (Приложение 1).
3.2 Алгоритм действий персонала при выявлении нежелательных побочных реакций (Приложение 2).
3.3 Протокол для определения степени достоверности причинно-следственной связи «лекарство-НПР» (Приложение 3).
3.4 Журнал учета выявленных неблагоприятных побочных реакций (НПР) при применении лекарственных средств и медицинских изделий (Приложение 4).
3.5 Отчет по мониторингу безопасности лекарственных средств и медицинских изделий в клинике /филиале ГБУЗ МО «МОКПТД» (Приложение 5).
3.6 ЧЕК-ЛИСТ выявления признаков НПР/неэффективности лекарственных препаратов, используемый при проведении служебного расследования (Приложение 6).
4. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на заведующих отделениями, клинического фармаколога и лиц, ответственных за осуществление мониторинга безопасности лекарственных средств, в части их касающейся.
5. Ответственным за заполнение отчета по мониторингу безопасности лекарственных средств в ГБУЗ МО «МОКПТД» назначить клинического фармаколога Аникина Георгия Станиславовича тел. +7 926 563-84-49 Эл. почта: Medi321@mail.ru (НПР клиническому фармакологу передают все филиалы, Клиника №1, Стационар «Сукманиха», Клиника №2 назначают ответственных из числа своих сотрудников).
5. Считать утратившим силу приказы ГБУЗ МО «МОКПТД»:
- от 09.09.2021 №273/21 «О регистрации нежелательных явлений при применении лекарственных средств в ГБУЗ МО «МОКПТД»;
- 09.09.2021 № 275/21 «Об утверждении стандартной операционной процедуры мониторинга эффективности и безопасности лекарственных препаратов в ГБУЗ МО «МОКПТД» для врачей и среднего медицинского персонала»
- от 16.10 2023 № 250/23 «О регистрации нежелательных явлений при применении лекарственных средств в ГБУЗ «МОКПТД»;
6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя главного врача по медицинской части Лапыреву И.А. и заместителя главного врача по амбулаторной работе Баронову О.Д.

Главный врач С.В. Смердин

Приложение 1
к приказу ГБУЗ МО «МОКПТД»
от «14» июля 2025 № 109/25

Порядок регистрации случаев побочных действий лекарственных препаратов, нежелательных реакций, серьезных нежелательных реакций, непредвиденных нежелательных реакций при применении лекарственных препаратов, индивидуальной непереносимости, отсутствии эффективности лекарственных препаратов, а также иных фактов и обстоятельств, представляющих угрозу жизни или здоровью человека при применении лекарственных препаратов в ГБУЗ МО «МОКПТД»

1. При выявлении случаев НПР, при применении лекарственных препаратов лечащему врачу необходимо незамедлительно информировать заведующего отделением и ответственного за осуществление мониторинга безопасности лекарственных средств.
2. При развитии НПР в выходные, праздничные дни и ночные часы медицинскому работнику необходимо передать информацию дежурному администратору. Заведующего отделением и врача-клинического фармаколога о развитии НПР необходимо информировать в ближайший рабочий день.
3. Лечащему врачу самостоятельно или совместно с ответственным за осуществление мониторинга безопасности лекарственных средств:

3.1 Определить степень достоверности причинно-следственной связи между развитием нежелательной лекарственной реакции и подозреваемым лекарственным средством по алгоритму Наранжо.

3.2 Заполнить «Извещение о нежелательной реакции на лекарственное средство или отсутствии ожидаемого терапевтического эффекта» (далее – извещение о НПР) в установленной форме и передавать копию ответственному за осуществление мониторинга НПР в ближайший рабочий день.

3.3 Сообщать следует:

- обо всех неблагоприятных побочных реакциях на новые лекарственные средства (новыми считаются препараты в течение 5 лет после их регистрации);
-о неожиданных НПР на "старые препараты";
- о серьезных нежелательных реакциях на все препараты;
- о неблагоприятных эффектах взаимодействия лекарственных средств;
- о неожиданных терапевтических эффектах (ранее неизвестных);
- о результатах наблюдений, в которых имеются четкие доказательства того, что препарат вызывает НПР (например, развитие аналогичной реакции на повторное назначение препарата);
- об изменениях лабораторных показателей, при которых отменяется препарат и меняется схема лечения заболевания;

- о развитии резистентности;
- о последствиях передозировки (случайной или преднамеренной);
- о последствиях ошибок при применении лекарственных средств (неправильный путь введения, отпуск или введение неправильного лекарства вследствие схожести упаковок или торговых наименований и др.).

4. Ответственному за осуществление мониторинга безопасности лекарственных средств необходимо проводить:

4.1 экспертизу (верификацию) извещения о НПР, по результатам которой принимается решение о регистрации извещения о НПР в системе Росздравнадзора;

4.2 регистрировать извещение о НПР в автоматизированной информационной системе Росздравнадзора (сайт www.roszdravnadzor.ru в разделе «фармаконадзор») в обязательных случаях выявления:

- серьезных нежелательных реакций, в том числе с летальным исходом или угрозой жизни;
- передачи инфекционного заболевания через лекарственный препарат;
- отсутствия заявленной эффективности лекарственных препаратов, применяемых при заболеваниях, представляющих угрозу для жизни человека, вакцин для профилактики инфекционных заболеваний, лекарственных препаратов для предотвращения беременности, когда отсутствие клинического эффекта не вызвано индивидуальными особенностями пациента и (или) спецификой его заболевания;
- нежелательных реакций, возникших вследствие злоупотребления препаратом, в случаях умышленной передозировки лекарственного препарата, при воздействии, связанном с профессиональной деятельностью, или в случаях использования лекарственного препарата в целях умышленного причинения вреда жизни и здоровью человека;

4.3 доводить результаты мониторинга эффективности и безопасности лекарственных препаратов при оказании медицинской помощи на заседаниях Формулярной (Врачебной) комиссии ГБУЗ МО «МОКПТД».

5. Заместителям главного врача по службам необходимо контролировать полноту и достоверность сведений о развитии НПР, представляемых ответственному за осуществление мониторинга безопасности лекарственных средств.

Приложение 2
к приказу ГБУЗ МО «МОКПТД»
от «14» июля 2025 № 109/25

Алгоритм действий персонала при выявлении нежелательных побочных реакций

1 Сообщить о НПР

Персоналу, непосредственно работающему с лекарственными препаратами (ЛП), при выявлении нежелательных побочных реакций (НПР), немедленно сообщить лечащему врачу пациента и заведующему отделением. При развитии НПР в выходные, праздничные дни и ночные часы необходимо информировать дежурного администратора. Заведующего отделением о развитии НПР и/или ответственного за мониторинг НПР в ближайший рабочий день.

2. Заполнить извещение о НПР

Лечащим врачом одновременно заполняется извещение о НПР, которое передается заведующему отделением и/или ответственному за мониторинг НПР

3. Провести служебное расследование

Ответственным лицам за осуществление мониторинга безопасности лекарственных средств в течение рабочего дня провести служебное расследование для исключения причин нежелательного явления или неблагоприятного события, связанных с действием медицинского персонала.

4. Передача информации в Росздравнадзор и

Направлять информацию (извещения) о неблагоприятном событии (инциденте) на лекарственные препараты в письменной или электронной форме через официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (http://www.roszdravnadzor.ru)
Срок передачи информации - в течение 15 рабочих дней, в случае серьезных НР - не позднее 3-х дней.
Копия Извещения вкладывается в медицинскую документацию и передается ответственному за осуществление мониторинга безопасности лекарственных средств

Приложение 3
к приказу ГБУЗ МО «МОКПТД»
от «14» июля 2025 № 109/25

Протокол для определения степени достоверности причинно-следственной связи "лекарство-НПР"

Таблица 1

Классификация степеней достоверности причинно-следственной связи "лекарство-НПР"

Определенная	Клинические проявления НПР, нарушения лабораторных показателей возникают в период приема препарата, не могут быть объяснены наличием существующих заболеваний и влиянием других факторов. Проявления НПР регрессируют после отмены лекарства и возникают вновь при повторном назначении препарата
Вероятная	Клинические проявления НПР, нарушения лабораторных показателей связаны по времени с приемом лекарства, вряд ли имеют отношение к сопутствующим заболеваниям или другим факторам, и которые регрессируют с отменой препарата. Ответная реакция на повторное назначение препарата неизвестна.
Возможная	Клинические проявления НПР, изменения лабораторных показателей связаны по времени с приемом препарата, но их можно объяснить наличием сопутствующих заболеваний или приемом других лекарств и влиянием химических соединений. Информация о реакции на отмену лекарства неясная.
Сомнительная	Клинические проявления НПР, изменения лабораторных показателей возникают при отсутствии четкой временной связи с приемом лекарства; присутствуют другие факторы (лекарства, заболевания, химические вещества), которые могут быть причиной их возникновения.
Условная	Клинические проявления НПР, нарушения лабораторных показателей, отнесенные к НПР, трудно оценивать. Необходимы дополнительные данные для оценки, или же эти данные в настоящее время анализируются.
Неклассифицируемая	Сообщения о подозреваемой НПР нельзя оценить, так как нет достаточной информации, или же она противоречива.

Для определения степени достоверности причинно-следственной связи "лекарство-НПР" применяется алгоритма Наранжо (табл.2).

Таблица 2

Алгоритм Наранжо для оценки причинно-следственной связи "НПР-лекарство"

	Вопросы	Да	Нет	Неизвестно
1.	Были ли ранее достоверные сообщения об этой НПР?	+1	0	0
2.	НПР возникла после введения (приема) подозреваемого лекарства?	+2	-1	0
3.	Улучшилось ли состояние больного (проявления НПР) после прекращения приема препарата или после введения специфического антидота?	+1	0	0
4.	Возобновилась ли НПР после повторного введения препарата?	+2	-1	0
5.	Есть ли еще причины (кроме подозреваемого лекарства), которые могли вызвать НПР?	-1	+2	0
6.	Было ли лекарство обнаружено в крови (или других жидкостях) в концентрациях, известных как токсические?	+1	0	0
7.	Была ли НПР более тяжелой после увеличения дозы и менее тяжелой после ее уменьшения?	+1	0	0
8.	Отмечал ли больной аналогичную реакцию на то же или подобное лекарство при прежних его приемах?	+1	0	0
9.	Была ли НПР подтверждена объективно?	+1	0	0
10.	Отмечалось ли повторение НПР после назначения плацебо?	-1	+1	0

Категории степеней достоверности взаимосвязи "НПР-лекарство" по шкале Наранжо в результате ответов на 10 вопросов определяются как:

определенная..... 9 и более баллов

вероятная ..... 5-8 баллов

возможная..... 1-4 балла

сомнительная..... 0 и менее баллов

Определения применяемые при организации деятельности по мониторингу эффективности и безопасности лекарственных препаратов для медицинского применения

Неблагоприятная побочная реакция - любая непреднамеренная и вредная для организма человека реакция, которая возникает при использовании лекарственного препарата в рекомендуемых дозах, и при которой доказана причинно-следственная связь с лекарственным средством.
Неблагоприятное побочное явление - любое неблагоприятное с медицинской точки зрения событие, возникающее во время лечения препаратом и не обязательно имеющее с ним причинно-следственную связь. Оно может только совпадать по времени с приемом препарата.
Серьезная неблагоприятная побочная реакция - любая непреднамеренная и вредная для организма человека реакция, приведшая к: смерти; состоянию, представляющему угрозу для жизни; состоянию, требующему срочной госпитализации или ее продления; инвалидности или значительной и стойкой нетрудоспособности; развитию врожденных аномалий; другим клинически значимым событиям
Непредвиденная побочная реакция - НПР, не включенная в инструкцию по медицинскому применению препарата в РФ.

Верификация - процедуры, выполняемые с целью подтверждения того, что данные, представленные в конечном отчете, соответствовали оригинальным наблюдениям. Проверка может касаться медицинских записей, сообщений о НПР, компьютерных распечаток, статистических анализов и таблиц.

Сбор информации о нежелательных побочных реакциях осуществляется методом спонтанных (добровольных) сообщений, в основе которого лежит добровольное или законодательно регламентированное предоставление информации о НПР в Росздравнадзор.

Спонтанное сообщение о НПР подается в виде извещения о НПР Таблица №3

Таблица 3

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ РЕАКЦИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

☐ Первичное

☐ Дополнительная информация к сообщению №_____ от_____

Данные пациента

Инициалы пациента (код пациента)*_____ Пол ☐ М ☐ Ж Вес_____ кг

Возраст_____ Беременность ☐, срок _____ недель

Аллергия ☐ Нет ☐ Есть, на _____

Лечение ☐ амбулаторное ☐ стационарное ☐ самолечение

Лекарственные средства, предположительно вызвавшие НР

	Наименование ЛС (торговое)*	Производитель	Номер серии	Доза, путь введения	Дата начала терапии	Дата окончания терапии	Показание
1							
2							
3							

Нежелательная реакция	**Дата начала НР**_____
Описание реакции* (укажите все детали, включая данные лабораторных исследований)	**Критерии серьезности НР:**
	☐ Смерть
	☐ Угроза жизни
	☐ Госпитализация или ее продление
	☐ Инвалидность
	☐ Врожденные аномалии
Дата разрешения НР _____	☐ Клинически значимое событие
	☐ Не применимо

Предпринятые меры

☐ Без лечения ☐ Отмена подозреваемого ЛС ☐ Снижение дозы ЛС

☐ Немедикаментозная терапия (в т.ч. хирургическое вмешательство)

☐ Лекарственная терапия

_____

Исход
□ Выздоровление без последствий □ Улучшение состояние □ Состояние без изменений
□ Выздоровление с последствиями (указать)_____ □ Смерть □ Неизвестно □ Не применимо

Сопровождалась ли отмена ЛС исчезновением НР?	□ Нет □ Да □ ЛС не отменялось □ Не применимо
Назначалось ли лекарство повторно? □ Нет □ Да	Результат_____ □ Не применимо

Другие лекарственные средства, принимаемые в течение последних 3 месяцев, включая ЛС принимаемые пациентом самостоятельно (по собственному желанию)

	Наименование ЛС (торговое)	Производитель	Номер серии	Доза, путь введения	Дата начала терапии	Дата окончания терапии	Показание
1							
2							
3							
4							
5							

Данные сообщающего лица
□ Врач □ Другой специалист системы здравоохранения □ Пациент □ Иной **Контактный телефон/e-mail:*** _____
Ф.И.О _____
Должность и место работы_____
Дата сообщения_____

* поле обязательно к заполнению

Сообщение может быть отправлено:

- e-mail: pharm@roszdravnadzor.ru,
- факс: +7(495)698-15-73,
- он-лайн на сайте npr.roszdravnadzor.ru
- почтовый адрес: 109074, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, строение 1

Приложение 4
к приказу ГБУЗ МО «МОКПТД»
от «14» июля 2025 № 109/25

Журнал
учета выявленных неблагоприятных побочных реакций (НПР) при применении лекарственных средств и медицинских изделий

№	Ф. И.О. пациента	№ медицинской карты пациента	ЛС		НПР			Дата информирования Регионального центра	Ф.И.О. сообщившего о НПР
			МНН	Торговое название	Дата возникновения	описание	Исход		

Приложение 5
к приказу ГБУЗ МО «МОКПТД»
от «14» июля 2025 № 109/25

Отчет по мониторингу безопасности лекарственных средств и медицинских изделий в клинике /филиале _____ГБУЗ МО «МОКПТД»

1. За отчетный период (год) _____ было зарегистрировано НПР:

Вид сообщения	Всего зарегистрировано за отчетный период	Направлено заполненных Карт-извещений в Росздравнадзор
Сообщений о неблагоприятных побочных реакциях (НПР) на лекарственные средства (ЛС)		
Сообщений о неблагоприятных побочных реакциях (НПР) на медицинские изделия (МИ)		

2. Если не все сообщения о выявленных НПР были направлены в Региональный центр, укажите причину _____

3. Выявлено серьезных реакций на ЛС, МИ _____, в том числе:

3.1. Приведших к летальному исходу - _____, указать данные о препаратах (торговое название, производитель, доза, вызвавшая эффект, путь введения), о пациентах (пол, возраст, основное заболевание), описание НПР.

3.2. Приведших к другим серьезным НПР:

Виды реакций	Торговое название ЛС, МИ	НПР	количество НПР
Выявлено реакций на ЛС, МИ, создавших угрозу жизни			
Выявлено реакций на ЛС, МИ, приведших к удлинению госпитализации			
Выявлено реакций на ЛС, МИ, приведших к стойкой или длительной потере трудоспособности или инвалидности			

4. Выявлено непредвиденных НПР _____ (не внесенных в инструкцию по применению ЛС, МИ)

торговое название ЛС, МИ	производитель	НПР

Ответственный за мониторинг безопасности ЛС и МИ в медицинской организации (ФИО, тел.)
_____

Приложение 6
к приказу ГБУЗ МО «МОКПТД»
от «14» июля 2025 № 109/25

ЧЕК-ЛИСТ выявления признаков НР/неэффективности ЛС, используемый при проведении служебного расследования

ЧЕК-ЛИСТ выявления признаков НЛР/неэффективности ЛС	**дата заполнения**		**комментарии**
ОТДЕЛЕНИЕ	**ИБ №**		
Ф.И.О пациента			
длительность госпитализации (сут).			**операции** *да *нет
триггеры НЛР/неэффективности ЛС	**указаны в ИБ**	**выявлены**	
факторы риска, в т.ч.: беременность			
пожилой возраст			
когнитивные расстройства			
нуждается в уходе, контроле выполнения назначений			
прием психотропных препаратов с медицинской целью			
прием психотропных препаратов с немедицинской целью			
патология почек в анамнезе с развитием ОПН /диализ			
патология почек в анамнезе с развитием ХПН			
патология печени в анамнезе			
кровотечения из ЖКТ в анамнезе			
отёки, полисерозит			
ХСН, аритмия			
аллергия в анамнезе			
лекарственная непереносимость, НЛР в анамнезе			
одновременный приём более 5 лекарственнных препаратов			
АБТ в предшествующие 6 мес			
Длительный приём ГКС, цитостатиков, иммуносупрессоров			
проявления НЛР	**указаны в ИБ**	**выявлены**	**препарат**
нефротоксичность			
снижение диуреза			
нарастание азотемии			
необходимость в проведении ГД			
гепатотоксичность			
желтуха			
боли в правом подреберье			
билирубин нарастание уровня/изменение			

соотношения фракций билирубина			
повышение АЛТ/АСТ/ГГТ >2 ВГН			
повышение ЩФ > 2 ВГН			
назначение гепатопротекторов			
гастро- и энтеропатии			
изжога, боли в эпигастрии			
кровотечение из ВОПТ			
назначение антисекреторных препаратов			
снижение уровня гемоглобина >25% от исходного			
назначение гемостатиков, гемотрансфузии			
Поражение легких, в т.ч.: Нарастание одышки			
Появление изменений на R-грамме ОГК без признаков инфекции			
Кардиотоксичность, в т.ч.: увеличение QT			
развитие аритмии			
нарастание признаков сердечной недостаточности			
нестабильность АД			
Нейротоксичность, в т.ч.: головокружение			
судороги			
расстройства сознания, возбуждение/заторможенность			
назначение транквилизаторов, седативных препаратов, антипсихотиков			
перевод в ОРИТ из-за расстройств сознания			
снижение слуха			
снижение зрения, изменение характера зрения			
падения			
аллергия (какая): кожный зуд			
кожные высыпания			
кашель, удушье			
отек Квинке, крапивница			
назначение антигистаминных препаратов, ГКС системно или топически			
инфекционные осложнения: *АБ-асс диарея и ПМК*			
появление диареи на фоне приёма АБ (более 3 р/сут)			
прекращение диареи после отмены АБ			
развитие пареза кишечника на фоне приема АБ			
Назначение протводиарейных перпаратов			
***грибковые осложнения*:** налет в полости рта, мукозит, изъязвление слизистой			
кандидоз пищевода (клиника, ЭГДС)			

зуд промежности, налет на слизистой НПО, отделяемое			
лихорадка на фоне адекватной АБТ			
верификация очагов			
Другое (указать)			
ЗАКЛЮЧЕНИЕ Выявлены признаки :			
Эксперт			
	подпись		/расшифровка подписи